

Reverie e Interpretação

Captando algo humano · Capítulo 4

Privacidade, reverie e técnica analítica

Thomas H. Ogden

Considero esta a tarefa mais elevada para duas pessoas: que cada uma proteja a solidão da outra.

R. M. Rilke, 1904.

Debussy acreditava que música era o espaço entre as notas. Pode-se dizer algo similar da psicanálise. Entre as notas das palavras ditas, que constituem o diálogo analítico, estão as reveries do analista e do analisando. Nesse espaço ocupado pelo interjogo de reveries é que se encontra a música da psicanálise. Este capítulo representa a tentativa de examinar certos métodos (técnicas), dos quais nós, analistas, dependemos para ouvir essa música.

Neste capítulo e no próximo, tentarei descrever três implicações distintas, mas inter-relacionadas, para a técnica psicanalítica, derivadas da compreensão da relação entre privacidade, comunicação e a vivência do “terceiro analítico intersubjetivo” (Ogden, 1992a, b; 1994a, b, c, d). Como se discutirá, acredito que a criação de um processo analítico depende da capacidade do analista e do analisando participarem do interjogo dialético dos estados de “reverie” (Bion, 1962), que são, ao mesmo tempo, privados e inconscientemente comunicativos.

Após discutir brevemente o conceito de terceiro analítico, abordarei o papel do uso do divã como componente da estrutura analítica, o que levará à discussão da relação do papel do divã com a frequência das sessões.

Proporei, então, que a “regra fundamental” da Psicanálise, tal como apresentada e descrita por Freud (1900, 1912, 1913), não ajuda na facilitação de condições para que o analisando (e o analista) gerem reveries e, na verdade, frequentemente impede a criação do processo analítico. Sugerirei uma nova conceituação da regra fundamental.

No próximo capítulo, reconsiderarei crenças habitualmente mantidas acerca do trabalho com sonhos em análise e sugerirei abordagens alternativas fundamentadas na concepção do processo analítico como um interjogo dialético das subjetividades do analista e do analisando, resultando na criação de um “espaço onírico intersubjetivo”. O sonho tido no curso da análise é, de certa maneira, o sonho do terceiro analítico. Será apresentado um fragmento de trabalho analítico em que se conceitua e trabalha um sonho como produto do espaço onírico analítico intersubjetivo.

O terceiro analítico

Nos últimos anos, desenvolvi uma concepção de processo psicanalítico baseada na ideia de que, além do analista e do analisando, há um terceiro sujeito da análise ao qual me referi como o “terceiro analítico intersubjetivo”, ou simplesmente “o terceiro analítico” (Ogden, 1992a, b; 1994a, b, c, d) (Ver Baranger, 1993 e Green, 1975 para concepções afins da intersubjetividade analítica). O terceiro sujeito (intersubjetivo) da análise está em tensão dialética com o analista e o analisando enquanto indivíduos separados, cada qual com suas próprias subjetividades. Analista e analisando, cada um participa da construção intersubjetiva inconsciente (o terceiro analítico), mas fazem-no de maneira

simétrica. Mais especificamente, a relação dos papéis do analista e do analisando estrutura a interação analítica de uma forma que privilegia, rigorosamente, a investigação do mundo objetual interno inconsciente do analisando. Isso se deve porque o propósito mais fundamental da relação analítica é ajudar o analisando a fazer mudanças psicológicas que lhe possibilitem viver sua vida de modo mais plenamente humano. Privilegiar a investigação da vida inconsciente do analisando dá-se através do uso que o analista faz de sua prática e experiência, ao empregar seu próprio inconsciente em função de receptor do “fluxo” (Freud, 1923a, p. 239) do inconsciente do analisando.

A experiência do paciente e do analista em relação ao terceiro analítico intersubjetivo é assimétrica, não só quanto à forma pela qual cada um colabora em sua construção e elaboração. É assimétrica também no sentido de que analista e analisando vivenciam o terceiro analítico no contexto da sua própria personalidade individual, que estrutura e desenvolve pela sua própria forma de organização psicológica, suas próprias estratificações e ligações de significados pessoais derivados da totalidade de sua história e do seu conjunto único de experiências vitais, seus modos próprios de organizar e experimentar sensações físicas, e assim por diante. Em suma, o terceiro analítico não é um evento único vivenciado de modo idêntico pelas duas pessoas; ao contrário, é um conjunto de experiências intersubjetivas conscientes e inconscientes, construído e vivenciado conjuntamente, mas de modo assimétrico, em que participam analista e analisando.

O papel do divã no processo analítico

Nesta parte da discussão, atendo-me a algumas implicações do conceito de terceiro analítico para a técnica na

medida em que se apoia em um elemento importante do enquadre analítico: o uso do divã.

Ao abordar a questão do papel do divã como um aspecto da estrutura analítica, é necessário começar com a difícil pergunta sobre que elementos são essenciais na constituição da psicanálise enquanto processo terapêutico. A estrutura deve servir ao processo e, portanto, a fim de determinar se um elemento da estrutura facilita de fato o processo psicanalítico, deve-se tentar delinear de modo amplo a natureza desse processo.

Evidentemente, está fora do objetivo deste capítulo discutir, exaustivamente, os elementos fundamentais constituintes da psicanálise enquanto processo terapêutico. Ao invés disso, ofereço simplesmente algumas reflexões sobre o assunto, que podem servir como ponto de partida para a investigação dessa questão. Para tanto, usarei como base a concepção de Freud dos elementos essenciais que definem a psicanálise como método de tratamento. Freud (1914) sustentava que “Qualquer linha de investigação que reconheça (...) estes dois fatos (transferência e resistência) e os tome como ponto de partida para seu trabalho, tem o direito de se chamar psicanálise (...)” (p. 16). Sugiro o seguinte aprimoramento da afirmação sucinta de Freud: talvez se deva considerar que a psicanálise não implica só o reconhecimento da transferência e da resistência, mas também a natureza do campo intersubjetivo dentro do qual se gera a transferência e a resistência. Especificamente, como foi discutido acima, tenho em mente a criação de um terceiro sujeito da análise, através do qual os fenômenos de transferência e de resistência recebem um significado simbólico no cenário analítico. Essa construção intersubjetiva (o terceiro analítico) é gerada através do interjogo dialético das subjetividades individuais do analista e do analisando, no contexto de seus papéis de analista e analisando.

O problema de definir a natureza do papel do divã como componente da estrutura analítica transforma-se, então, no problema de conceituá-lo no processo de facilitar um estado mental em que o terceiro analítico possa ser criado, experimentado, elaborado e usado por analista e analisando. O uso da experiência no e do terceiro analítico envolve a criação de símbolos no diálogo analítico (símbolos predominantemente, mas não exclusivamente, verbais) para aspectos do mundo objetual interno do analisando, até então não verbalizáveis nem pensáveis.

Freud (1913) considerava “fazer o paciente deitar-se no divã, enquanto eu sento atrás dele e fora do seu campo visual” (p. 133) dois elementos essenciais, inter-relacionados do setting analítico, nos quais ele “insistia” (p. 134). Tanto o uso do divã quanto o fato de o analista estar “fora do campo visual” permitiam a Freud “entregar-me à minha corrente de pensamentos inconscientes” (p. 134). Muito embora ele tenha, originariamente, introduzido o uso do divã como forma de organização para ajudar o paciente a “concentrar a atenção em sua auto-observação” (Freud, 1900, p. 101), a ênfase de Freud (1911-1915), na discussão quanto ao uso do divã em seus “Artigos sobre técnica”, não era a respeito do papel de facilitador da capacidade de associação livre do paciente. Ao contrário, o foco principal de Freud, nesses artigos, estava na maneira pela qual o uso do divã dá ao analista a privacidade necessária para fazer seu trabalho: “Não consigo suportar ser olhado (...) enquanto escuto o paciente (...)” (1913, p. 134). Essa frase é frequentemente vista como uma manifestação de uma idiosincrasia pessoal de Freud, ou até como um aspecto de psicopatologia dele. Acredito que tais leituras desconsideram a grande importância que Freud dava à necessidade de construir condições, dentro da estrutura do setting analítico, em que se pudessem gerar e utilizar as reveries do analista. Freud (1912) insistia que a tarefa do analista era “simplesmente escutar” (p. 112). Acredito que a ordem formal

de “simplesmente escutar” era o jeito muito condensado usado por Freud para sugerir que o analista tentasse ficar tão inconscientemente receptivo quanto possível ao inconsciente do paciente e evitasse atolar-se em esforços conscientes (processo secundário) de organizar sua experiência.

Em suma, Freud (1913) acreditava que o uso do divã e a privacidade do analista em sua posição “fora da vista”, atrás do divã, eram componentes essenciais da estrutura de apoio, “a estrutura” da psicanálise. Tal arranjo ajuda a dar condições de privacidade nas quais o analista pode entrar em um estado de reverie em que ele se “entrega à corrente de (seus) pensamentos inconscientes” (p. 134) e torna seu próprio inconsciente receptivo ao inconsciente do analisando. Nessa discussão está implícita a ideia de que, ao usar o divã, o analisando pode sentir um alívio semelhante de ser encarado e pode se entregar, mais facilmente, ao fluxo de seus próprios pensamentos inconscientes (e talvez, também, aos do analista).

Alguns comentários sobre técnica

No início da análise, quando pela primeira vez introduzo a ideia do uso do divã ao paciente, explico que faz parte da minha técnica ter o paciente deitado no divã, enquanto eu me sento na cadeira atrás dele. Continuo a explicar que faço isso, porque descobri que essa disposição me dá privacidade para vivenciar e pensar a respeito do que ocorre, de um modo que me é necessário para realizar o trabalho analítico. Acrescento que o analisando pode também achar que essa forma de trabalho lhe permite vivenciar seus próprios pensamentos e sentimentos de modo diferente de seu jeito habitual de pensar, sentir e experimentar sensações físicas. O fato de apresentar o uso do divã enfatizando minha própria necessidade, bem como a do analisando, de uma área de privacidade, um espaço psicológico (tanto no sentido literal como no metafórico) no qual pensar e gerar experiências, representa uma declaração importante ao paciente a respeito da minha concepção do método analítico e da sobreposição de nossos papéis nele.

No que foi dito até aqui, está implícito que considero as circunstâncias necessárias para ambos, analista e paciente, poderem atingir o estado de reverie como condição necessária para a condução da análise. É possível comparar estas condições com a necessidade do campo estéril para o cirurgião realizar a cirurgia. Em ambos os casos, do analista e do cirurgião, conhecimento, treino e habilidade técnica estão sujeitos a se tornarem inúteis se não existir o contexto necessário ao trabalho. Vim a considerar o uso do divã como elemento facilitador importante na criação das condições em que se possa gerar e utilizar a reverie. Ao mesmo tempo, o uso do divã, por parte do paciente (enquanto o analista senta atrás dele, fora de seu campo visual), não é mais do que um dos vários conjuntos de fatores que contribuem para as condições facilitadoras da criação do processo analítico. Além do mais, o fato de o paciente usar o divã de forma alguma garante que se esteja gerando e utilizando um processo analítico (ver Goldberger (1995) para a discussão sobre o uso do divã pelo paciente como possibilidade de encenação (enactment) transferencial).

A presente discussão sobre o papel do divã como facilitador das condições para a elaboração de estados de reverie não pretende sugerir que o analista deva insistir (de forma explícita ou implícita) que todo paciente de análise use sempre o divã (Fenichel, 1941; Frank, 1995; Jacobson, 1995; Lichtenberg, 1995). Há períodos da análise em que usar o divã fica assustador demais para ser tolerado. Nessas circunstâncias, seria antiterapêutico tentar ignorar e deixar de analisar a ansiedade do paciente, pressionando-o a usar o divã. Esse tipo de comportamento, por parte do analista,

representaria provavelmente uma atuação (acting-out) contratransferencial.

O divã na prática analítica

Tendo como pano de fundo a discussão anterior sobre o uso do divã (incluindo a posição do analista, fora do campo visual, atrás dele) como parte da estrutura analítica projetada para possibilitar “estados sobrepostos de reverie”, gostaria de fazer uma breve consideração sobre uma questão relacionada à prática analítica: devem os analistas restringir o uso do divã a pacientes que tenham quatro ou mais sessões por semana? Essa pergunta requer que retornemos à questão do que consideramos como elementos definidores do processo analítico. Visto que a técnica deve facilitar o processo analítico, a questão vem a ser o exame do papel do divã como facilitador da criação do processo analítico. Em outras palavras, parece que a natureza do processo analítico, como nós o entendemos, está ligada a uma frequência específica de encontros (ou seja, quatro ou mais sessões por semana), ou o processo analítico se define por uma qualidade específica da experiência psicológica interpessoal, independente da frequência das sessões?

Em uma tentativa de abordar essas questões inter-relacionadas, apresentarei, esquematicamente, uma série de pensamentos relativos à minha concepção da natureza do processo analítico, que irá, por fim, referir-se à relação do uso do divã com a frequência de sessões.

1. A psicanálise é um processo psicológico-interpessoal que requer certas condições em que analista e analisando, em conjunto (e assimetricamente), geram um terceiro sujeito inconsciente da análise.
2. A análise da experiência inconsciente (transferência-contratransferência) requer receptividade a estados de

reverie, tanto por parte do analista quanto do analisando, com a qual recontextualizar (mais precisamente, contextualizar de novo) aspectos inconscientes da experiência.

3. Elos associativos e novas contextualizações entre aspectos (amplamente) inconscientes da experiência requerem que a privacidade que leva ao estado de reverie seja permitida a ambos, analista e analisando.

4. Usar o divã (com o analista sentado atrás dele, fora do campo visual do paciente) favorece as condições em que analista e analisando podem, cada um, ter privacidade suficiente para entrar nos seus próprios estados de reverie, estados que envolvem uma área de “sobreposição”. (“A psicoterapia ocorre na sobreposição de duas áreas do “brincar”*, a do paciente e a do terapeuta” [Winnicott, 1971a, p. 381].)

5. Segue-se, então, que o uso do divã pelo paciente (e a privacidade do analista atrás dele) fornece um meio de facilitar o acesso, por parte do analista e do analisando, a um “espaço do brincar”, uma área de estados sobrepostos de reverie, condição necessária para elaboração e análise do terceiro analítico intersubjetivo inconsciente (cf. Grotstein, 1995).

6. Seja qual for a maneira pela qual se defina a análise, parece essencial incluir nessa definição a tentativa de gerar e vivenciar o terceiro analítico inconsciente e fomentar um estado de reverie através do qual analista e analisando possam perceber o “fluxo” (Freud, 1923a) da construção inconsciente “compartilhada” (e, ainda

assim, individualmente vivenciada). Define-se melhor a empreitada analítica não pela forma (aí incluída a frequência das sessões), mas pela substância, que envolve a análise da transferência-contratransferência (incluindo ansiedade/defesa), à medida que se dá forma a esses fenômenos no vivenciar e na interpretação do terceiro analítico.

Segundo minha experiência, de modo geral, o aumento da frequência de sessões semanais melhora a capacidade de gerar estados sobrepostos de reverie do analista e do analisando. Acho que não faz sentido algum comprometer um conjunto de condições, sob as quais a análise está sendo conduzida, sacrificando outras condições que conduzem à criação do processo analítico. Eu especialmente teria grande dificuldade de compreender a lógica por trás da decisão de trabalhar com um paciente face a face, porque as condições que levam à criação do processo analítico ficaram comprometidas como resultado de limitações que levaram a uma frequência de encontros considerada, pelo analista, menor do que a ideal. Consequentemente, a não ser que existam razões importantes para não usar o divã em um dado caso, conduzo todo o meu trabalho analítico com o paciente fazendo uso do divã, independentemente do número de sessões semanais.”

1. O uso da técnica analítica a serviço da criação do processo analítico (por exemplo, uso da reverie para compreender minha experiência de transferência-contratransferência e uso desse entendimento para interpretar a ansiedade transferencial-contratransferencial dominante) não muda em relação ao número de sessões semanais de atendimento. Por exemplo, não confio em sugestão, persuasão, reassuramento, e assim por diante, para pacientes de uma sessão semanal nem para os de quatro, cinco ou seis sessões semanais.

Reenunciando a regra fundamental

Ainda que Freud não tenha introduzido o termo “regra fundamental” até 1912, já era um conceito central no seu pensamento sobre técnica analítica em *A interpretação dos sonhos* (1900). Em 1913, Freud formulou enunciado mais aprimorado e completo a respeito “da regra fundamental da técnica psicanalítica que o paciente deve observar” (p. 134). Esta deve ser comunicada a ele (o analisando) bem no início:

Mais uma coisa antes de começar. O que você me disser deve ser diferente de uma conversa comum, em um aspecto (...) Você se sentirá tentado a dizer a si mesmo que isto ou aquilo é irrelevante aqui, ou pouco importante, ou que não tem sentido algum e, então, não seria necessário dizê-lo. Nunca se deve ceder a tais críticas, mas dizer o que pensa apesar das críticas - de fato, você deve dizer o que pensa exatamente porque não quer dizer (...) Então, diga o que lhe vier à mente (...) Por fim, nunca esqueça de que prometeu ser absolutamente honesto, e nunca deixar nada de fora porque, por uma razão ou por outra, é desagradável de contar. (p. 134-135)

Uma revisão recente da literatura (Lichtenberg e Galler, 1987) revelou que “poucos artigos na literatura têm como tópico principal a modificação (...) da regra fundamental, e uns poucos sugerem modificações incidentais” (p. 52). Em um comentário mais elaborado sobre a regra fundamental, Etchegoyen (1991) afirma: “Podem surgir circunstâncias especiais que nos aconselhem a seguir um caminho diferente do habitual, sem que isso queira dizer, em absoluto, que podemos nos afastar da regra (fundamental)” (1991, p. 65).*

* “Edição Brasileira, 1987, p. 43. (N. da T.)

Vou me referir a diversos aspectos da questão da regra fundamental. Parece-me que qualquer consideração sobre o papel da “regra fundamental” deve começar por relacionar esse aspecto da técnica à nossa concepção do processo analítico como um todo, visto que a técnica deve facilitar o processo. De forma bem abrangente, a psicanálise pode ser descrita como um processo psicológico interpessoal com o intuito de ampliar a capacidade do analisando de estar vivo enquanto ser humano. Ainda que um grande número de analistas tenha feito contribuições essenciais a essa concepção de análise, Winnicott talvez seja o principal arquiteto da moderna concepção de psicanálise, em que o foco central do processo analítico foi ampliado da tarefa de tornar consciente o inconsciente (na linguagem do modelo topográfico), ou de transformar o id em ego (na linguagem do modelo estrutural). Para Winnicott (1971b), o processo analítico tem como preocupação central a expansão da capacidade do analista e do analisando de criarem “um lugar para viver” em uma área de vivência localizada entre realidade e fantasia.

O processo psicanalítico, tal qual concebido por Winnicott (1963), demanda, da técnica analítica, a avaliação plena da importância da tensão produtiva entre privacidade e relação interpessoal:

Ainda que pessoas saudáveis se comuniquem e apreciem fazê-lo, o contrário é igualmente verdadeiro, ou seja, cada indivíduo é isolado, permanentemente não comunicável, permanentemente desconhecido, na verdade, não encontrável (...) No cerne de cada pessoa há um elemento incommunicável que é sagrado e cuja preservação é muito preciosa. (p. 187)

Com base nessa concepção do que é ser ente humano, Winnicott comenta a psicanálise como uma teoria (ainda que as implicações de seus comentários sobre a técnica analítica sejam claras): “Podemos entender o ódio que as pessoas sentem pela psicanálise, que penetrou profundamente na personalidade humana e que representa uma ameaça ao indivíduo, no que diz respeito a sua necessidade de estar secretamente isolado” (p. 187). Logo depois, ele acrescenta: “Devemos nos perguntar se nossa técnica permite ao paciente comunicar aquilo que ele não está comunicando?” (p. 188). Essa é a questão que cria o pano de fundo para eu reexaminar a regra fundamental.

Em trabalhos anteriores (Ogden, 1989a, b; 1991b), discuti minha concepção do papel do isolamento pessoal e da proteção do indivíduo contra a tensão contínua que faz parte inescapável do viver na matriz imprevisível das relações objetais humanas (1991b). Ressaltei o papel de manutenção da vida das formas de experiência regidas pelas sensações (“autística-contígua” [1989a, b]), na criação de uma suspensão temporária das relações, tanto com a mãe/analista enquanto objeto, quanto com a mãe/analista como ambiente. Como resultado dessa visão do papel central da privacidade/isolamento pessoal na experiência humana saudável, em minha prática analítica não instruo o paciente a tentar dizer tudo o que lhe venha à mente, não importando o quanto isso venha a ser “ilógico, constrangedor, ou trivial, ou aparentemente irrelevante” (Greenson, 1971, p. 102). Tampouco acredito ser suficiente “suavizar” a regra fundamental com comentários tais como: “Entendo que a tarefa de dizer tudo o que lhe vem à mente seja difícil ou impossível”).

Em vez disso, tenho por hábito convidar simplesmente o paciente, de forma não verbal, a começar a análise por meio de uma conduta minha, nas sessões iniciais, que lhe mostre o que significa estar em análise (Ogden, 1989b). Nos momentos iniciais da primeira sessão, talvez eu não diga coisa alguma, ou talvez pergunte ao paciente: “Por onde devemos começar?” Faço o esforço de apresentar ao paciente, na sessão inicial (e em cada sessão subsequente), a natureza de um diálogo psicanalítico (que se

caracteriza pela combinação de qualidades que o analisando não terá encontrado em nenhum outro lugar, uma vez que o diálogo analítico é diferente de qualquer outra forma de discurso humano). Tento fazê-lo de maneira tal que isso não se anuncie como uma “técnica” (i.e., como uma forma prescrita estagnada). A “regra fundamental”, na prática analítica atual, corre o risco de se tornar uma imposição inalterável para o analista e para o analisando. Frequentemente é tratada como ornamento estático e não examinado do panorama analítico, contendo todo o poder sufocante do uso repetido que Freud (1913) fazia das palavras “dever” e “insistir”, na descrição da apresentação da regra fundamental ao analisando.

Aconselhar o paciente a dizer tudo o que lhe venha à mente parece-me antitético ao esforço de criar o processo analítico. Se eu fizesse isso, estaria em desacordo com minha concepção de experiência analítica como algo baseado no interjogo dialético das capacidades de reverie do analista e do analisando (Ogden, 1994a, d). Para o paciente é tão importante saber que tem liberdade de ficar em silêncio, como saber que tem liberdade de falar. Privilegiar a fala ao silêncio, a revelação à privacidade, o comunicar ao não comunicar parece-me tão antianalítico quanto privilegiar a transferência positiva em detrimento da negativa, a gratidão à inveja, o amor ao ódio, o modo depressivo de gerar experiência aos modos esquizoparanoide e autístico-contíguo (Ogden, 1986; 1988b).

A questão é que no momento em que essa dialética (por exemplo, a tensão dialética de amor e ódio, revelação e privacidade, comunicar e não comunicar) desmorona em uma “direção” ou em outra (por exemplo, quando superestimar a revelação levou a igualar privacidade com resistência) o indivíduo (ou o par analítico) entra no terreno da psicopatologia. Desta perspectiva, a psicopatologia envolve diversas formas de o indivíduo (ou par analítico) não conseguir ficar vivo no processo de criar e de preservar

essas tensões dialéticas e, em vez disso, embrenhar-se na tarefa de criar substitutivos para a experiência de vitalidade, por exemplo, na forma de prazer perverso, excitação maníaca, construções como-se, e assim por diante. Creio que iniciar ou fundamentar a atividade analítica em um ideal manifesto (ou não manifesto) que incorpore um colapso da tensão dialética de comunicar e não comunicar em direção à revelação represente um convite a uma relação patológica. O resultado é, frequentemente, a criação de uma doença iatrogênica em que a capacidade de reverie se paralisa ou é levada a se ocultar, tornando assim muito menos provável que venha a ocorrer um processo analítico verdadeiro.

Neste ponto, gostaria de oferecer um breve exemplo clínico do colapso da dialética de privacidade e comunicação que resultou em uma experiência de morte psicológica.

Fui consultado pelo dr. E. sobre uma análise conduzida por ele e que lhe parecia “estagnada” por muitos anos. O analista sentia-se oprimido pela paciente, sra. J., apesar de dizer que gostava bastante dela. O analista disse-me que, frequentemente, queria poder diminuir a frequência das sessões de cinco para duas ou três vezes por semana, ou talvez encerrar a análise de uma vez. No curso da prolongada consulta, pedi ao dr. E. que apresentasse anotações escritas de diversas sessões, incluindo um relato detalhado de suas respostas contratransferenciais à paciente.

O dr. E. descreveu a maneira pela qual a paciente preenchia as sessões com uma conversa aparentemente introspectiva que “parecia não ir a lugar algum”. Disse-me que, frequentemente, lutava contra o sono. O dr. E. acrescentou que a descrição do clima da análise estaria incompleta se ele omitisse o fato de que havia momentos em que se sentia dolorosamente constrangido durante as sessões com a paciente. O dr. E. disse que a sra. J. poderia ser extremamente

mordaz em sua crítica “sempre perspicaz” a respeito do seu gosto para se vestir, ligeiras mudanças de peso, comportamento, decoração do consultório, e assim por diante. A paciente fazia os comentários como quem pede desculpas e esses eram frequentemente prefaciados por observações tais como “tenho medo de ofendê-lo ou de machucá-lo se lhe disser o que estou pensando”.

Em um dos poucos sonhos contados, a paciente estava em uma praça pública precisando tomar banho, mas descobriu que nenhuma das cabinas tinha cortinas nos chuveiros. Havia uma porta modesta e despretensiosa que parecia uma porta de banheiro e que conduzia a um adorável apartamento decorado nas cores preferidas da paciente, vermelhos e marrons profundos. A sra. J. disse não ter pensamentos sobre o sonho. Cogitei em voz alta com o dr. E. se o sonho poderia refletir um sentimento doloroso e implícito de falta de privacidade na transferência-contratransferência. A porta “modesta” conduzia a um espaço vital (um espaço em que a paciente poderia estar viva em privacidade). Era um lugar que refletia seu estilo próprio. Eu disse que as cores vermelho profundo e marrom pareciam sugerir que a vivacidade sexual fazia parte do que estava sendo imaginado e vivenciado pela paciente no sonho e, talvez, almejada na transferência.

Durante a discussão desse sonho, perguntei ao dr. E. se ele dissesse à sra. J. que sua tarefa era dizer tudo que lhe viesse à mente. Ele disse que falara, no começo da análise (sete anos atrás), mas a instrução nunca mais fora mencionada por nenhum dos dois.

Levantei a possibilidade de que o sentimento do dr. E. de ser intrusiva e dolorosamente observado e exposto pela sra. J. poderia refletir algo da experiência projetada da paciente de ter seu mundo

interno sadicamente roubado. Parecia possível que esta fantasia destrutiva de pilhagem ocorria porque ambos, analista e analisanda, tinham ficado subjugados por uma autoridade imaginária, a “regra fundamental” e tudo que isto simbolizava para eles. (É claro que nenhum fato singular, como a instrução do analista para a paciente dizer tudo que lhe vier à mente, determinará o curso de uma análise. No caso discutido, as instruções do analista, relativas à regra fundamental, foram a manifestação de uma construção intersubjetiva que se desenvolveu gradativamente em que analista e analisando estavam presos em uma armadilha.)

Ocorreram profundas discussões desse aspecto da transferência-contratransferência durante os meses sucessivos de consulta. Um elemento dessa discussão envolveu a revelação de que o dr. E. tomara a regra fundamental como um “dado”, em parte porque isto servira de componente principal no contexto em que sua análise fora conduzida. O dr. E. reconheceu que sua falta de reflexão sobre este aspecto da interação analítica poderia ser a atuação* do seu ressentimento a respeito deste aspecto da sua própria experiência analítica e suspeitou (com base em outras reveries ocorridas durante as sessões com a sra. J.) que, na análise atual, pudesse estar envolvido em uma fantasia em que havia uma reversão retaliatória de papéis. O dr. E. finalmente disse à paciente que acontecimentos recentes da análise tinham-no feito rememorar o sonho dela sobre os chuveiros públicos sem cortinas. Ele ligou essa imagem com

* No original: acting out. (N. da T.)

o fato de tê-la instruído a dizer tudo que lhe viesse à mente. O dr. E. disse à paciente ter esperança de que a análise por ele conduzida pudesse resultar em mudanças tanto nele quanto nela. Uma mudança que tinha ocorrido durante os sete anos anteriores fora o que sentia em relação a pedir à paciente que dissesse tudo que lhe viesse à mente. Chuveiros deveriam ter cortinas e a análise deveria ter lugar para a privacidade. A paciente ficou bastante aliviada com os comentários do dr. E. Mais tarde, na sessão, ela disse que achara muito significativo o fato de ele ter-lhe falado com tanta sinceridade. O dr. E. disse-me que não se lembrava de a sra. J. alguma vez ter expressado gratidão de forma tão direta e comovente.

Reexprimindo a regra fundamental

Se fosse colocar em palavras, para mim mesmo, minha visão do papel do analisando com relação a comunicar e a não comunicar no setting analítico, suponho que começaria pela ideia de que comunicação e privacidade devem ser consideradas como dimensões da experiência humana, cada qual criando e preservando a vitalidade, “o senso de real” (Winnicott, 1963, p. 184) do indivíduo e da experiência analítica. Formulado como breve enunciado ao analisando, teria a seguinte forma: “Considero nossos encontros como um momento em que você pode dizer o que quiser, quando quiser, e para eu responder do meu jeito. Ao mesmo tempo, deve sempre haver lugar para a privacidade de cada um de nós”. É um enunciado longo e bastante estranho, e não tenho certeza de alguma vez ter dito exatamente assim a um analisando. Acho que me soa bombástico, em parte, por ser um comentário imaginário destituído do contexto pessoal de uma interação humana específica. Não obstante, capta

boa parte do que eu, frequentemente, digo a mim mesmo, quando se apresenta a ocasião, do que digo ao paciente.

É frequente o analisando ter lido a respeito da “regra fundamental” ou inventado uma versão para si (por exemplo, tomando como base a experiência com pais que lhe exigiam “dizer tudo”) ou “aprendido” a regra fundamental por experiência em uma ou mais análises anteriores. Nessas circunstâncias foi essencial falar com o paciente a respeito da concepção dele das “regras da análise” relativas à associação livre, i.e., as regras dele relativas ao que é dito e ao que é deixado por dizer, entre o que deve fazer-se público e o que “se permite” permanecer privado. Diversos pacientes me disseram, baseados em suas experiências anteriores de análise, que vieram a supor que todas as análises evoluíriam no final para duas formas de diálogo, uma falada, outra secreta, por causa da “regra de dizer tudo”. No decorrer dessas discussões, mais cedo ou mais tarde, esclareci que minha concepção de análise não requer que o analisando tente falar tudo o que lhe vem à mente. Tanto o analisando quanto eu devemos estar sempre livres para a comunicação conosco (tanto em palavras como em sensações), bem como para a comunicação um com o outro.

2. Essa visão do papel do analisando sobrepõe-se a comentários breves feitos por Altman (1976) e Gill (comunicação pessoal relatada por Epstein, 1976) sobre suas versões próprias da regra fundamental. Altman (1976) sugere que se fale ao paciente de modo a transmitir-lhe que o analisando tem “o direito de dizer qualquer coisa” (p. 59). Gill (comunicação pessoal relatada por Epstein, 1976) sugere que se diga ao analisando: “Você pode dizer o que quiser” (p. 54). Essas duas afirmações sobrepõem-se ao meu modo de pensar, embora deem menos ênfase do que eu à importância central da privacidade na experiência analítica.

Não me parece que análises conduzidas ou supervisionadas por mim, enquanto espaço analítico em que a privacidade é tão valorizada quanto a comunicação, levem a impasse analítico em que o silêncio, por exemplo, sirva como forma não analisável de resistência. Quando ocorreram silêncios defensivos, por períodos longos, descobri a importância de reconhecer e de interpretar tanto a necessidade de privacidade do paciente quanto sua necessidade de fazer uma comunicação transferencial através do silêncio (Coltart, 1991). (A comunicação transferencial feita através do silêncio é, frequentemente, uma forma de transferência como “situação total” [Joseph, 1985].)

No decorrer do tempo, em uma análise, a ideia de que o analisando só diz o que quer dizer e mantém a privacidade como algo “sagrado” (Winnicott, 1963) mostra-se ainda mais complicada do que parece à primeira vista, já que nem sempre o analisando mostra clareza a respeito do que gostaria de dizer ou mesmo de quem “ele” é. O analisando descobre que a primeira pessoa do singular é, na verdade, plural: há muitos “Eu”. Apesar de tudo, o paciente quer dizer certas coisas enquanto “ele” (outro aspecto de sua experiência de si) acha que “ele” não pode dizer coisas que “ele” quer dizer. Além do mais, há coisas que ele sente que gostaria de dizer, mas não sabe o que são. (Ver Ogden, 1992a, b, para a discussão do sujeito dialeticamente constituído/descentrado da psicanálise). Uma evolução importante da análise ocorre quando o analisando torna-se capaz de diferenciar e compreender algo a respeito da relação entre aspectos diferentes de si, por exemplo, entre não querer dizer algo (porque quer “manter para si” por enquanto) e não se sentir capaz de dizer algo enquanto almeja que o analista o ajude a encontrar um jeito de ser capaz de pôr em palavras. Esses conflitos entre aspectos distintos da experiência do self permanecem frequentemente irreconhecíveis e, por isso, não analisáveis, quando a análise é conduzida sob a égide da enunciação do

analista, e o paciente se defendendo parcialmente do uso da regra fundamental. Esse tipo de impasse pode tomar a forma de uma fantasia inconsciente do paciente de que a análise exige que ele se submeta a um tipo de “eviscação psíquica”. As relações inconscientes de objeto que constituem essa fantasia permanecem não analisáveis na medida em que o analista estiver impondo sem refletir um contexto de vivência real governado pela expectativa/exigência que o analisando “diga tudo o que lhe vem à mente”.

O papel do analista e a regra fundamental

Freud (1923a) acreditava que a regra fundamental da associação livre tivesse sua contrapartida no esforço do analista em “entregar-se à sua própria atividade mental consciente, em estado de atenção flutuante” (p. 239). O analista tenta, “na medida do possível, evitar a reflexão e a instrução de expectativas conscientes, (e tenta) não fixar na sua memória nada de específico que tenha ouvido e, dessa maneira, capturar o fluxo do inconsciente do paciente com o seu próprio inconsciente” (p. 239). “O trabalho de interpretação do analista não deve ser submetido a regras severas e deixa boa parte do jogo a critério da habilidade do tato do médico” (p. 239). “Ou, para dizer claramente em termos de técnica: ‘Ele’ (o analista) deve simplesmente escutar e não se preocupar se está ou não retendo qualquer coisa na mente” (1912, p. 112).

A ênfase de Freud em descrever o “trabalho” do analista não reside no fato de o analista ver ou revelar tudo (mesmo a si próprio), mas sim em criar condições para um tipo particular de receptividade e de “brincar” mental. Freud pede ao analista para tentar deixar seu inconsciente entrar em ressonância com o inconsciente do paciente. O analista, ao “simplesmente escutar”, busca não “fixar” (não

lembrar ou entender muito) e sim, ao contrário, “simplesmente” usar seu próprio estado de receptividade para dar sentido ou “pegar o fluxo” da experiência inconsciente do paciente. Parece-me que o estado psicológico aqui descrito por Freud como “simplesmente escutar” é o mesmo estado psicológico a que Bion (1962) se refere como “reverie”, estado caracterizado pela ausência de “memória e desejo” (Bion, 1967).

Embora o estado de receptividade inconsciente do analista ao inconsciente do analisando seja descrito como o fato de o analista dar “atenção igual” (Freud, 1912, p. 112) a si próprio (ou seja, como contrapartida da exigência feita em relação ao paciente, dentro da regra fundamental), o esforço necessário para entrar em um estado de “atenção igualmente flutuante” (p. 111) mal e mal parece representar “atenção igual” à exigência de que o analisando diga tudo o que lhe vem à mente. Se a “exigência” feita ao paciente (ou, melhor dizendo, ao papel designado ao paciente) fosse genuinamente complementar ao papel que Freud divisava para o analista, na criação de um estado de atenção igualmente flutuante, acredito que o par analítico poderia entrar mais facilmente em um tipo de relacionamento em que seria possível, para analista e analisando, “captar o fluxo”, apreender da “corrente” de construções inconscientes criadas na análise. Sob essas condições, analista e analisando, cada qual por sua vez, estão em situação de “posicionar seu inconsciente como órgão receptivo ao inconsciente transmissor” (Freud, 1912, p. 115) do outro e receptivo às construções inconscientes coproduzidas (ainda que assimetricamente) pelo “terceiro analítico”.